

2017 호흡기학 2차 문제 및 풀이

1. 다음 중 폐색전증의 진단에 관한 내용이다. 맞는 항목을 하나 고르시오.

- ① 같은 부위에서 흉통이 반복되면 폐경색증을 의심해야 한다.
- ② D-dimer 수치가 증가하면 폐색전증을 배제할 수 있다.
- ③ 단일 채널 흉부CT가 주된 영상 진단 방법이다.
- ④ 환기스캔 정상, 관류스캔 이상으로 불일치가 되면 진단 가능하다.
- ⑤ 심장초음파를 이용하면 폐동맥 내 혈전을 직접 관찰할 수 있다.

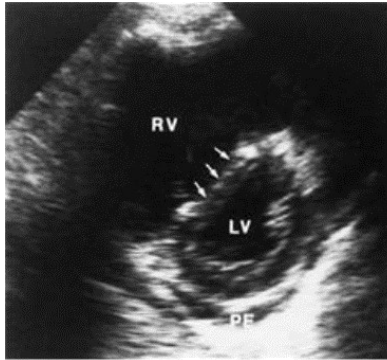
문제번호	1	교수님	김경찬
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 진단		
답	4		
해설	틀린 보기를 정정하면 다음과 같다 1. 폐색전이 폐경색으로 진행하는 경우는 굉장히 드문 편이다. (100% 틀린 보기는 아닌 거 같은데 잘 모르겠음....) 2. D-dimer는 가장 흔히 쓰이는 lab수치인데 정상일 때 PE를 배제할 수 있다. 하지만 D-dimer가 높을 때 반드시 PE라고 할 수 있는 건 아니다. 3. 단일 채널이 아닌 Spiral Chest CT가 주된 영상 진단 방법이다. 5. 초음파는 혈전을 위해 보기 찍는 게 아니고 D-shaped LV를 보기 위해 찍는다.		

2. 다음 중 폐색전증의 항응고 치료에 관한 내용이다. 틀린 항목을 하나 고르시오.

- ① 헤파린은 저분자량헤파린에 비해 헤파린유발혈소판감소증(HIT) 빈도가 높다.
- ② 와파린은 헤파린과 5-7일간 중복 사용한 후 와파린 단독으로 사용한다.
- ③ 헤파린 투여량은 aPTT 2.0~3.0 범위로 조절해야 한다.
- ④ 임신 중 폐색전증에는 저분자량헤파린을 사용할 수 있다.
- ⑤ 와파린 투여시 브로콜리, 청국장을 많이 섭취하면 효과가 증가한다.

문제번호	2	교수님	김경찬
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 항응고 치료		
답	5		
해설	15년 야마에 있는 문제와 유사한 문제이다. 나머지 보기는 강의록에서 찾을 수 있고 5번 보기도 강의록에서 찾을 수 있다. 녹색채소류(브로콜리, 시금치 등)나 콩류, 청국장에는 Vitamin K가 많이 포함되어 있기 때문에 warfarin의 농도가 감소하여 항응고 효과를 저하시킨다.		

3. 47세 남자가 갑작스런 호흡곤란이 발생하여 전원되었다. 6개월전 교통사고로 두개내 출혈이 발생하여 타병원 신경외과에서 응급으로 두개내 수술을 받았다. 일반 병동에서 누운 채 지내던 중 호흡곤란이 발생하였다. 내원 당시 혈압은 70/40 mmHg, 맥박 138/분, 호흡수 26/분, 체온 37.4도로 불안정한 상태이었다. 흉부CT 소견은 우측 폐동맥이 혈전으로 막혀있는 소견을 보였다. 응급으로 시행한 심장 초음파 결과는 다음과 같았다(그림 참조). 현재 이 환자에서 우선적으로 고려해야 하는 치료방법을 한가지 고르시오.



- ① IVC filter
- ② Rivaroxabn
- ③ Graduated compression stocking
- ④ Catheter embolectomy
- ⑤ Tissue plasminogen activator (tPA)
- ⑥ Low molecular heparin
- ⑦ Pulmonary thromboendarterectomy
- ⑧ Warfarin

문제번호	3	교수님	김경찬
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 치료		
답	4		
해설	수술력, 계속 누워서 지냄, CT소견 설명, 초음파에서 보이는 D-shaped LV등 모든 조건들이 폐색전증을 암시하고 있다. 강의록의 증례 D와 일치하고 두개 내 출혈이 있었으니 출혈경향(+), SBP가 100미만이므로 쇼크(+)이다. 치료는 embolectomy 한다. 답지엔 5번이라고 표기돼 있는데 잘 못 체크돼 있는 듯		

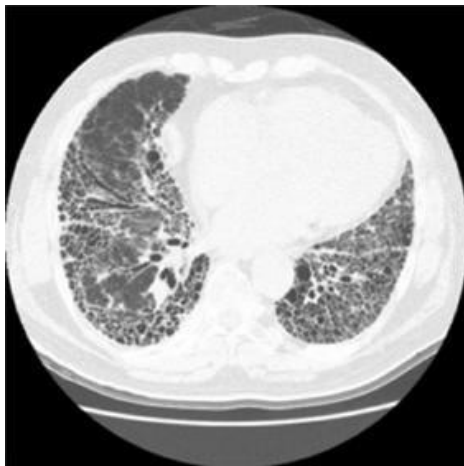
4. 57세 남자 환자가 외상에 의한 소장 파열로 입원하여 수술하였다. 수술 2일째 호흡곤란 및 흉통이 발생하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 102/분, 호흡수 20/분, 체온 36.8도이었다. 동맥혈 가스 분석상 PaO2 88 mmHg, SaO2 98%이었다. 흉부CT상 좌우측 폐동맥이 thrombus에 의해 부분적으로 막혀 있는 소견을 관찰하였다. 심장 초음파 결과에서는 RV dysfunction의 소견은 관찰되지 않았다. 현재 이 환자에서 가장 우선적으로 시행해야 할 치료방법을 하나만 고르시오.

- ① IVC filter
- ② Rivaroxabn
- ③ Graduated compression stocking
- ④ Catheter embolectomy
- ⑤ Tissue plasminogen activator (tPA)
- ⑥ Low molecular heparin
- ⑦ Pulmonary thromboendarterectomy
- ⑧ Warfarin

문제번호	4	교수님	김경찬
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 치료		
답	2		
해설	수술력, 입원 이후 호흡곤란, CT소견 설명을 볼 때 폐색전증을 의심할 수 있다. 출혈경향(-), 쇼크(-)이므로 강의록에 증례A와 비슷하고 항응고제 치료를 해 주면 된다.		

5. 70세 남자가 3개월 전부터 숨이 많이 차서 왔다. 1년 전부터 숨이 차기 시작했으며 6개월 전부터는 기침도 있었다. 혈압 120/75mmHg, 맥박 97회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.0℃였다. 양측 아래쪽가슴에서 숨을 들이 마실 때 거품소리가 들렸으며, 손가락 끝은 곤봉모양으로 멍푹하였다. 혈액 및 폐기능검사 결과와 고해상 가슴 컴퓨터촬영 사진이다. 진단은?

혈액검사 백혈구 9,500/mm³, 혈색소 17.3 g/dL, 혈소판 254,000/mm³,
적혈구용적률 56% 폐기능검사 강제폐활량(FVC) 정상예측치의 55%,
1초간 강제날숨량(FEV1) 정상예측치의 78%,
1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) 82%



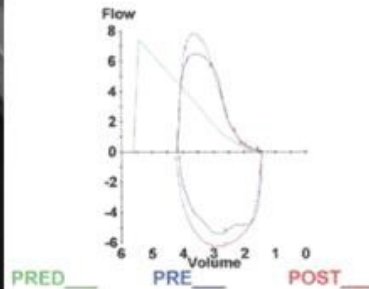
- ① 기관지확장증
- ② 특발성폐섬유증
- ③ 만성호산구성폐렴
- ④ 만성폐쇄성폐질환
- ⑤ 비특이사이질폐렴

문제번호	5	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 진단		
답	2		
해설	여러 가지 단서가 있는데 FVC의 감소, 곤봉지를 보고 간질성 폐질환을 제일 먼저 의심해야 한다. HRCT 소견은 subpleural honeycombing 을 보여주는데 이는 IPF(특발성 폐 섬유증)의 아주 전형적인 사진이다. 참고로 KMLE에서 모든 IPF문제는 HRCT사진을 알아보기만 하면 풀 수		

	있다. 그래도 간질성 폐질환에서 나타나는 각각의 lab소견들(상승, 하강, 정상)에 대해서는 잘 알아두도록 하자
--	---

6. 70세 남자가 6개월 전부터 점점 더 숨이 차서 병원에 왔다. 기침은 자주하였으나 가래는 거의 없었다. 평지를 천천히 걸어도 숨이 차다고 하였다. 흡연은 하지 않았다. 혈압 125/80mmHg, 맥박 78회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃였다. 양쪽 아랫가슴에서 미세거품소리가 들렸다. 가슴 X-선 사진, 유량용량곡선 이다. 다음으로 시행할 검사는?

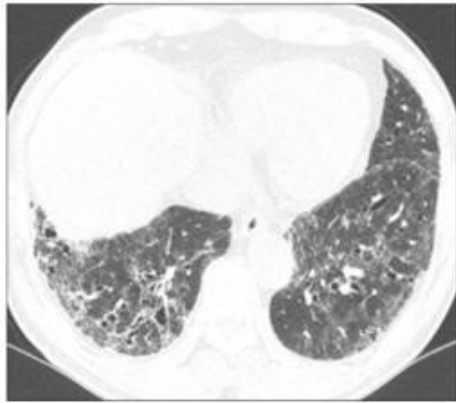
- ① 심초음파
- ② 혈장 D-이량체
- ③ 양전자방출단층촬영
- ④ 메타콜린 기관지유발검사
- ⑤ 가슴고해상컴퓨터단층촬영



문제번호	6	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 진단		
답	5		
해설	호흡곤란, 가래 없는 마른기침, 양측 폐 하부에 미세 거품소리, Xray 소견상 bibasilar reticular infiltration(미만성 침윤) 이런 단서들이 간질성 폐질환의 특징들이다. 간질성 폐질환의 진단과 staging에 HRCT(가슴 고해상 컴퓨터 단층 촬영)는 필수이다. flow volume curve는 폐 실질 손상으로 인해서 FVC가 줄고 그래프가 우측으로 이동한 Restrictive pattern을 보이는 것 같은데 정확히는 모르겠음		

7. 57세 남자가 두 달 전부터 숨이 차다고 왔다. 마른기침이 있었고, 열은 없었다. 평소 다 큰 질환이나 호흡기 이외 증상은 없었고, 비흡연자였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈액 검사, 폐기능 검사 결과와 가슴컴퓨터단층촬영 사진이다. 다음으로 시행할 검사는?

혈액검사 백혈구 9,000/mm³ (중성구 30%, 림프구 68%, 호산구 2%), 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 350,000/mm³ 폐기능검사 강제폐활량(FVC) 정상예측치의 70%, 1초간 강제날숨량(FEV1) 정상예측치의 88%, 1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) 84%



- ① 심초음파
- ② 가래 그람염색
- ③ 환기/관류 스캔
- ④ 가는바늘흡인검사
- ⑤ 비디오보조흉강경 폐생검

문제번호	7	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 진단		
답	5		
해설	호흡곤란, 마른 기침, 양측 폐에서 미세 거품소리, HRCT 사진(강의록 사진과 똑같음)을 보니 간질성 폐질환이 의심된다. 사진을 보면 ground glass opacity, consolidation을 확인할 수 있고 비특이 사이질 폐렴NSIP임을 알 수 있긴 하다. 정확한 분류를 모르더라도 일단 HRCT 에 이후에 시행할 검사는 흉강경 폐조직 검사 혹은 비디오 보조 흉강경 생검(VATS)등 biopsy를 하는 것이다. HRCT 사진 주고 다음 검사를 묻는 문제는 KMLE에서 흔하게 볼 수 있는 유형이기도 하다.		

8. 45세 남자가 건강검진에서 발견된 가슴 X선 사진 이상으로 왔다. 비흡연자로 호흡기 증상은 없었다. 피부 병변이나 시력장애는 없었고 심잡음도 들리지 않았다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영사진이다. 진단은?

- ① 신경종(neuroma)
- ② 사르코이드증(sarcoidosis)
- ③ 기관지낭(bronchogenic cyst)
- ④ 폐색전증(pulmonary embolism)
- ⑤ 과민폐렴(hypersensitivity pneumonitis)



문제번호	8	교수님	박재석? 노병학?
해설자	신나일	감수자	
주제	사르코이드 증		
답	2		
해설	간질성 폐질환의 여러 분류 중 하나이다. 특징적인 임상 증상은 없고 무증상인 경우도 많은 병이다. KMLE에서도 우연히 발견된 흉부X선 이상 소견으로 내원했다는 경우가 많은데 Xray와 Chest CT영상이 결정적인 단서이다. Xray에서 bilateral hilar lymphadenopathy, CT에서 화살표로 표시된 임파선 주위에 덩어리 같은 게 보이는 걸 보고 사르코이드 증을 의심할 수 있다. 강의록 사진과 비교해 보면 stage1처럼 보인다. 참고로 정확한 진단을 위해선 biopsy로 비건락성육아종을 확인해야 한다.		

9. 59세 남자가 직장검진 가슴X선 사진 이상으로 내원했다. 기침, 가래, 발열, 가슴통증은 없었다. 담배는 피우지 않았고 지난 20년간 건물철거작업을 했다. 혈압은 128/72mmHg, 맥박 64회/분, 호흡 18회/분, 체온은 36.2였다. 목 주위에 림프절은 만져지지 않았고, 호흡음은 정상이었다. 가슴X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 진단은?

- ① 석면증
- ② 면폐증
- ③ 폐면지증
- ④ 규소폐증
- ⑤ 과민성 폐렴



문제번호	9	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	직업성 폐질환		
답	1		
해설	박순호 교수님은 수업시간에 문제와 답을 다 보여주셨기 때문에 공부를 안 해서 정확한 해설을 하기는 힘들다π 석면증을 의심하는 대에 건설업에 오래 종사 했다는 게 결정적인 단서이다. 영상 소견에서는 pleural plaque, thickening, calcification이 보인다.		

10. 44세 남자가 점점 심해지는 호흡곤란 때문에 병원에 왔다. 28세부터 채석장에서 근무하고 있다. 다음은 단순 흉부 사진이다. 맞게 설명한 것은?



- ① 온석면이 유발 물질이다.
- ② 거의 대부분 폐쇄성 폐기능 장애를 보인다.
- ③ 폐결핵이 병발하기 쉽다.
- ④ 직장을 그만두면 병변이 호전된다.
- ⑤ 급성으로 진행되는 경우가 흔하다.

문제번호	10	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	직업성 폐질환		
답	3		
해설	15년 2차 시험과 유사한 문제이다. 환자는 채석장에서 오래 일 했다고 했는데 규소가 규폐증 을 일으킬 수 있다. 규폐증은 결핵, 폐암 등과 관련이 있다. 틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 석면이 유발물질인 병은 석면증(Asbestosis)이다. 2. fibrosis가 진행되어 제한성 폐기능 장애를 보인다. 4. 원인물질 노출이 중단되어도 fibrosis는 진행된다. 5. 원일 물질 최초 노출 후 15~20년 후에 문제가 된다.		

11. 장기흡연자에서 흔히 볼 수 있는 폐질환에 속하는 것은?

- ① Respiratory bronchiolitis
- ② Desquamative interstitial pneumonia
- ③ Langerhans histiocytosis
- ④ Usual interstitial pneumonia
- ⑤ All of above

문제번호	11	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 병리		
답	5		
해설	13년도 야마 관련해서 필기총이 따로 정리해 줬던 내용이다. 수업중에 언급한 적은 없는데 RB, DIP, LH, UIP, RB-ILD cancer등 많은 병이 흡연과 관련이 있다. Diffuse alveolar damage는 흡연과 관련성이 적다. 교수님이 은퇴하셨으니 다른 병리와 교수님이 말을 거라 18년엔 어떤 문제가 나올 지는 모르겠음		

12. 다음 간질성 폐렴에서 예후가 가장 불량한 질환(들)은?

- ① Cryptogenic organizing pneumonia (COP) and cellular NSIP
- ② Desquamative interstitial pneumonia (DIP) and cellular NSIP
- ③ Interstitial lung fibrosis of collagen vascular disorder
- ④ DIP and Hypersensitivity pneumonitis
- ⑤ UIP with emphysema

문제번호	12	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 병리		
답	5		
해설	13년도 야마 문제와 수업 때 언급하신 내용을 보면 UIP + emphysema는 예후가 나쁘다. 다른 질병과의 비교는 잘 모르겠음..		

13. Usual interstitial pneumonia (IPF) 병변의 특징이 아닌 것은?

- ① 부분적으로(patchy) 교원질 축적이 많은 섬유성 비후를 볼 수 있음
- ② Honeycomb structure를 볼 수 있음
- ③ 림프구 침윤과 혈관 증식변화가 현저함
- ④ Fibroblastic foci를 볼 수 있음
- ⑤ 폐실질에 섬유성 변화가 진행성이며, 주로 폐저부 및 변연부에 현저함

문제번호	13	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	간질성 폐질환의 병리		
답	3		
해설	강의록, 수업 내용을 참고하면 다른 보기에 대한 단서를 찾을 수 있다. lymphocyte가 침윤하는 점은 Hypersensitivity pneumonitis등 다른 병에 대한 설명이다.		

14. 바이러스성 폐렴에 관한 기술에서 틀린 사항은?

- ① 림프구 침윤을 흔히 볼 수 있음.
- ② 폐간질 부위(interstitial areas)에 주 병변을 보임
- ③ 감염된 세포핵 내에 봉입체(inclusion)를 볼 수 있음
- ④ 폐포 내에 광범위한 호중구성 삼출액(exudate) 소견을 보임
- ⑤ 모두(1-4) 바르게 기술됨

문제번호	14	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	바이러스성 폐렴		
답	4		
해설	강의록을 참고하면 다음과 같다. 바이러스성 폐렴의 병리학적 morphology로는 1. lymphocytic infiltration 2. interstitial pneumonitis pattern의 patch inflammation 3. inclusion body(특히 CMV의 경우 Owl's eye) 등이 있다. 4. alveoli는 free of exudate이면서 hyaline membrane(폐포가 손상 받은 흔적) 특징이다.		

15. 폐결핵에 관련된 사항에서 맞는 것은?

- ① Ghon complex는 결핵의 초기에서 볼 수 있는 소견임
- ② 괴사성 육아종성 병변이 관찰됨
- ③ 광범위한 괴사를 보이는 경우 다수의 acid fast bacilli를 병변에서 관찰할 수 있음
- ④ 환자의 면역이 저하된 경우 속립성 결핵(miliary tuberculosis) 양상을 보임
- ⑤ 모두(1-4) 바르게 기술됨

문제번호	15	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	폐결핵의 병리		
답	5		
해설	15년 2차 야마와 유사하다. 강의록, 수업 내용에서 확인할 수 있다. 1. Ghon complex는 early TB에서 나타난다. 2. 환자의 면역이 약하면 광범위한 괴사를 보이는 육아종 병변이 관찰된다. 3. 많은 양의 결핵균에 의해 광범위한 괴사를 보일 수 있다. 4. 환자의 면역이 약하면 Miliary TB로 진행 가능하다.		

16. 50세 남자가 5일 전부터 심해진 기침과 누런 가래로 병원에 왔다. 어렸을 때부터 가래가 많았다고 하였다. 활력 징후는 정상이며, 양쪽 가슴에서 뽁뽁거림(rhonchi)이 들렸다. 가슴 X선 사진과 가슴컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 치료은?

- ① 항생제
- ② 항바이러스제
- ③ 글루코코르티코이드
- ④ 지속성 베타2작용제
- ⑤ 폐엽절제술



문제번호	16	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	기관지 확장증		
답	1		
해설	심한 기침, 누런 가래만 보아도 현재 무언가에 감염된 상황이고 짝더라도 항생제 치료로 답을 찍을 수 있어야 한다. 기관지 확장증의 전형적인 증상으로 만성 기침, 화농성 가래, 반복되는 호흡기 감염 등이 있다. 신체 병적 소견으로는 crackle, rhonchi, clubbing finger 등이 있는데 이 문제에서는 HRCT만 봐도 눈에 띄게 넓어진 기관지들과 signet ring sign (기관지 벽의 비후)를 보고 기관지 확장증임을 알 수 있다. 치료는 기관지 확장의 회복 보다는 진행을 막고 증상을 호전시키는 방향으로 가야 한다. 감염을 치료하기 위한 항생제 투여, 객담 배출이 필요하다.		

17. 65세 남자가 한 달 전부터 숨이 차서 병원에 왔다. 2년 전부터 계단을 오를 때 숨이 차다고 느껴왔고 기침이 자주 있었다. 한 달 전부터 기침, 가래가 있으면서 평소보다 더 숨이 차다고 하였다. 40갑년의 흡연자였다. 혈압 122/80 mmHg, 맥박 74회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.4도였다. 가슴 청진에서 양쪽 모두 호흡음이 감소되어 있었다. 폐기능검사와 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 적합한 검사는?

강제폐활량(FVC): 정상예측치의 82%
 1초간 강제날숨량(FEV1): 정상예측치의 63%
 1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 65%

- ① 기관지내시경
- ② 심초음파검사
- ③ 가슴 컴퓨터단층촬영
- ④ 메타콜린 기관지유발검사
- ⑤ 기관지확장제 투여 후 기도가역성검사

문제번호	17	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	폐기능 검사		
답	5		
해설	2차시험의 베이스 업을 위해 다시 1차 시험의 범위에서 문제가 나왔었다. FEV1/FVC가 65이고 정상인 70보다 작으므로 폐쇄성이 있다고 해석할 수 있다. 증상, 흡연력을 비추어 볼 때 천식이나 COPD가 의심이 되는데 폐쇄성 환기장애를 특징으로 하는 질환에서 기류 폐쇄의 가역성을 확인하기 위해서는 기관지 확장제 흡입 후 검사를 해야 한다.		

18. 폐쇄성수면무호흡증에서 지속기도양압(continuous positive airway pressure)을 적용할 때 다음의 보기 중에서 호전을 기대할 수 있는 것은?

- ① 비만
- ② 고혈압
- ③ 당뇨병
- ④ 우울증
- ⑤ 심근경색증

문제번호	18	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	Sleep apnea		
답	2		
해설	다른 보기도 답이 될 근거가 조금씩이나마 있긴 하지만 강의록과 16야마를 기준으로 생각해보면 2번이 제일 일리가 있다. 수면무호흡증으로 자주 깨면 sympathetic tone이 올라가서 고혈압, 부정맥 등의 심혈관계 기능부전이 생기는데 수면무호흡증의 치료를 통해 호전을 기대할 수 있을 것이다. CPAP으로 치료했다는 사실은 이 문제에서 별로 안 중요한 듯		

19. 다음 중에서 무호흡-저호흡 지수(apnea-hypopnea index)가 29인 수면무호흡증후군 환자

CPAP 치료에 실패한 경우 시도할 수 있는 치료법은?

- ① Oral appliances
- ② High flow nasal oxygen
- ③ Corticosteroid nasal spray
- ④ Uvulopalatopharyngoplasty
- ⑤ hypoglossal nerve stimulation

문제번호	19	교수님	
해설자	신나일	감수자	
주제	Sleep apnea		
답	1, 4?		
해설	AHI가 29이면 중등도의 OSAHS(폐쇄성 수면무호흡증)이고 침습적인 치료가 필요한 상황이다. 중등도 혹은 중증 OSAHS 치료로는 CPAP, Oral appliance, 외과적치료(uvulopalatopharyngoplasty)가 있다. hypoglossal nerve stimulation은 경증 치료인데.. 왜 답이라고 체크되었는		

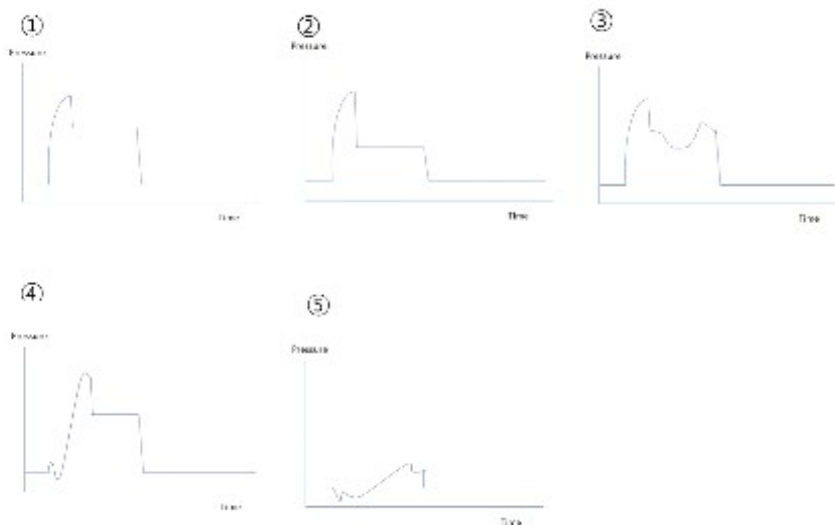
	지 모르겠음
--	--------

20. 다음 중에서 중환자에서 요구하는 최소한의 혈색소(Hb) 수치는 얼마인가?

- ① 3 g/dL
- ② 3 g/dL
- ③ 7 g/dL
- ④ 14 g/dL
- ⑤ 21 g/dL

문제번호	20	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	중환자의학		
답	3?		
해설	수업 때 딱히 언급 안 하셨던 것 같은데... 혈액학에서 수술 후 환자의 Hb을 7 이상으로 유지해야 한다는 식의 내용을 본 것 같음		

21. 다음의 그림은 일회환기량을 일정하게 공급하는 용적조절환기방식으로 기계환기를 사용할 때 측정한 압력-시간 곡선이다. 기도 저항이 가장 클 것으로 예측되는 경우는?



문제번호	21	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	중환자의학		
답	2		
해설	강의록에서 압력-시간 곡선의 Peak Pr와 Plateau Pr의 차이가 기도저항이라고 언급했다. 수업 때 시험에 낸다는 식으로 언급하셨었는데 제일 높은 지점과 평탄한 지점과의 차이가 가장 큰 2번이 답이다.		

22. 호흡근의 해부생리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 횡격막은 5경수에서 7경수 신경근에서 기시한 횡격막 신경의 지배를 받는다.
- ② 일반적으로 호흡 보조근은 갈비뼈를 아래쪽으로 움직이게 하는 함으로써 흡기를 돕는다.
- ③ 정상인에서 평상시 호기는 횡격막의 수동적 반동보다는 복부압력에 의해 공기가 외부로 배출된다.
- ④ 하부 경추신경손상 환자는 누운 자세에서 측정한 폐활량이 앉은 자세에서 측정한 폐활량보다 적다.
- ⑤ 혀와 인후두 근육은 개구리 호흡법이라 불리는 혀인두 호흡법(glossopharyngeal breathing)에 필수적인 근육들이다.

문제번호	22	교수님	김두한
해설자	신나일	감수자	
주제	호흡재활		
답	5		
해설	강의록과 수업 내용으로 틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 횡격막은 C3~C5에서 기시한 횡격막 신경의 지배를 받는다. 2. Accessory muscle들은 대부분 inspiratory에 관여하는 근육들이며 갈비뼈를 위쪽으로 움직이게 한다. 3. Resting 상태에서의 호흡은 대부분(75%)이 횡격막의 운동으로 인해 발생한다. 4. lower cervical spinal cord injury 환자는 intercostal & abdominis에 weakness가 생긴다. Vital capacity 제목의 슬라이드를 보면 lower C SCI에서 VC sit << VC sup이다. 누운 자세에서의 폐활량이 앉은 자세일 때보다 더 크다. 5. 수업시간에 언급했던 내용임		

23. 호흡재활의 설명으로 옳은 것은?

- ① 공기누적훈련(air stacking exercise)은 흡기근 저항운동이다.
- ② 근육병 환자에서 공기누적훈련은 예상 폐활량의 30%미만으로 감소될 경우 시작한다.
- ③ 기침보조기(mechanical insufflation-exsufflator)는 기관절개 없이도 분비물을 관리할 수 있다.
- ④ 공기누적훈련은 폐의 반동압(recoil pressure)을 감소시키기 때문에 보조 기침을 방해하는 단점이 있다.
- ⑤ 기침보조기는 큰 폐 기포(bulla)가 있는 경우 안전하게 사용할 수 있다.

문제번호	23	교수님	김두한
해설자	신나일	감수자	
주제	호흡재활		
답	3		
해설	강의록의 내용에서 보기들을 확인하면 다음과 같다. 1. 공기 누적 훈련은 흡기근 저항 운동이 아니라 폐 compliance, lung growth를 유지하기 위한 훈련이다. 2. 예상 폐활량의 70% 미만으로 감소될 경우 시작한다. 3. 기침보조기는 공기로만 빼내는 거니깐 기관절개 없이도 분비물을 관리할		

	수 있다.(13야마) 4. 관련 없는 설명임. 그리고 보조 기침을 방해하지는 않는다. 5. bulla가 없어야 한다.
--	--

24. 73세 남자가 우측 흉부 불편감을 주소로 내원하였다. 열, 기침, 가래 등은 없었다. 호흡 곤란을 호소하지 않았다. 최근 2개월 사이에 약 3kg 정도의 체중 감소가 있었다. 신체검진에서 혈압은 90/50mmHg, 호흡수 18회/분, 맥박 78회/분, 체온 36.3℃였다. 시진에서 흉부에 외상을 입은 흔적은 없었고 청진에서 우측 폐하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 흉부 방사선 사진에서 흉수가 발견되어 천자를 시행하였고 흉수는 붉은색이며 RBC 15,000/ μ l였다.

진단은?

- ① 농흉
- ② 악성 흉수
- ③ 결핵성 흉막염
- ④ 췌장질환과 연관된 흉수
- ⑤ 결체조직질환과 연관된 흉수

문제번호	24	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	악성 흉수		
답	2		
해설	기침, 가래 없는 호흡곤란 증상과 CXR소견으로 흉수를 확인할 수 있다. 최근 체중감소, 1만 개 이상의 RBC를 보니 malignant effusion일 가능성이 높다. 교수님께서 문제와 답을 미리 알려주셨기 때문에 공부를 거의 안 해서 정확한 해설이 어려움		

25. 65세 남자가 2주 전부터 시작된 우측 흉통과 열을 주소로 응급실로 내원하였다. 흉통은 숨을 들이 쉴 때 악화되었다. 기침은 간간히 있으나 가래는 없다. 신체검진에서 혈압 100/60 mmHg, 호흡수 22회/분, 맥박 96회/분, 체온 38.3℃였다. 청진에서 우측 폐하부에서 호흡음이 감소되어 있었다. 흉부 방사선은 다음과 같다. 우측에서 흉수 천자를 시행하였다. 검사실 소견으로 일치할 것으로 생각되는 것은?



- ① Pleural pH 7.5, Serum pH 7.4
- ② Pleural LDH 200 U/L, Serum LDH 400 U/L
- ③ Pleural protein 2.0 g/dL, Serum total protein 6.0 g/dL
- ④ Pleural glucose 120 mg/dL, Serum glucose 120 mg/dL

⑤ Pleural WBC count 15,000/ μ l, Serum WBC count 15,000/ μ l

문제번호	25	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	흉막 삼출		
답	5		
해설	effusion이 의심되는 CXR 소견이다. Light's criteria를 참고하여 exudate일 기준을 생각한다면 문제를 풀 수 있다. 교수님께서 문제와 답을 미리 알려주셨기 때문에 공부를 거의 안 해서 정확한 해설이 어려운데 exudate를 감별하는 것은 임상적으로 굉장히 중요한 부분이다.		

26. 폐 선암에서 10~35%로 흔하게 발견되고 폐암 치료에도 응용되는 유전자 돌연변이가 발생하는단백질은?

- ① ALK
- ② PD-1
- ③ EGFR
- ④ KRAS
- ⑤ CTLA-4

문제번호	26	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	폐종양		
답	3		
해설	교수님께서 문제와 답을 미리 알려주셨기 때문에 공부를 거의 안 해서 정확한 해설이 어려운		

27. 38세 여자가 건강검진에서 발견된 흉부방사선 사진 이상소견으로 내원하였다. 가슴 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자에서 다음으로 시행할 것은?

- ① 기관지내시경
- ② 과거 사진과 비교
- ③ 경피적 폐 세침생검
- ④ 양전자방출컴퓨터단층촬영
- ⑤ 3개월 후 흉부방사선 사진 추적관찰



문제번호	27	교수님	박순호
------	----	-----	-----

해설자	신나일	감수자	
주제	폐종양		
답	2		
해설	노병학 교수님 수업에도 언급됐던 내용인데 Xray에서 발견된 종괴는 과거 사진과 비교해서 growth 속도를 보는 게 중요하다		

28. 58세 여자가 2개월간 지속된 기침, 혈담 때문에 병원에 왔다. 가슴 CT 사진이다. 확진을 위해 어떤 검사를 시행할 것인가?



- ① 폐기능 검사
- ② 자기공명영상촬영
- ③ 골수천자 생검
- ④ 혈액 미생물 배양검사
- ⑤ 경피적 폐 생검검사

문제번호	28	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 종양의 진단		
답	5		
해설	증상과 영상 소견을 보니 폐 종양이 의심된다. 정확한 진단과 staging을 위해 경피적 폐 생검검사가 필수적이다. 교수님께서 문제와 답을 미리 알려주셨기 때문에 공부를 거의 안 해서 정확한 해설이 어려움		

29. 다음 그림에서 우상엽에 실선 부위 종괴는 편평상피세포폐암 4cm 이고 같은 우상엽 내에서와 종격동 기관분지하 림프절 위치의 검은 색 부위는 종양세포가 추가로 발견된 곳이다. 이 환자의 폐암병기는?

- ① Stage IIA
- ② Stage IIB
- ③ Stage IIIA
- ④ Stage IIIB
- ⑤ Stage IV

문제번호	29	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 종양의 병기		
답	3		
해설	TNM staging 표를 참고하면 된다.		

	4cm이므로 T2a 동측 mediastinal, subcarinal LN에 전이됐으므로 N2 원격 전이 없으므로 M0 종합하면 Stage IIIa이다.
--	---

30. 급성호흡곤란증후군(acute respiratory distress syndrome)으로 내원한 환자에게 체외막 산소공급

(extracorporeal membrane oxygenation)을 적용하기에 가장 적절한 경우는?

	Plateau pressure (cmH2O)	Duration (days)	Organ failure	PaO2/FiO2
①	<30	>7	Single	>150
②	>30	<7	Three	<100
③	>30	<7	Single	<100
④	>30	<7	Single	>150
⑤	>30	>7	Single	<100

문제번호	30	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	ARDS		
답	3		
해설	ECMO는 치료보다는 유지를 위한 처치이고 굉장히 severe한 환자에게만 쓴다. ARDS의 기준으로는 Acute하고 다른 장기(심장)로 인한 질병이 아니어야 한다. PaO2/FiO2는 낮고 고원부 기도 내압이 높을 수록 severe하다.		

31. 급성호흡곤란증후군의 회복과정으로 급성호흡곤란증후군 시작 후 2형 폐포세포가 1형 폐포세포로 분화가 시작하는 시기로 가장 적절한 것은?

- ① 1일
- ② 3일
- ③ 7일
- ④ 14일
- ⑤ 21일

문제번호	31	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	ARDS		
답	3		
해설	문제에서 묻는 시기는 증식기이며 7일에서 21일까지 지속된다.		

32. 33세 여자가 3일 전부터 미열, 흉통과 호흡곤란이 있어 내원하였다. 흉통은 숨을 깊게 들이쉴 때 더 심해지는 양상이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 가장 먼저 시행해야 할 검사는?

- ① 폐기능검사
- ② 기관지 내시경
- ③ 폐환기 관류검사

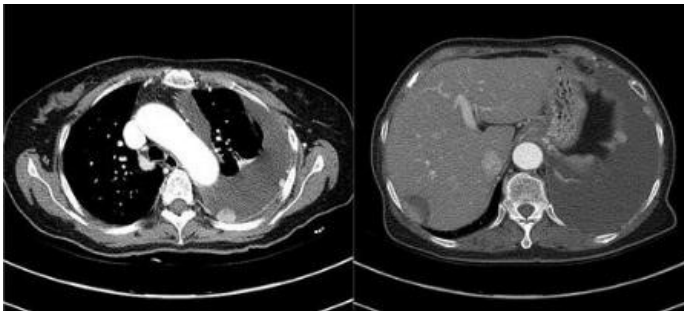
- ④ 도플러 초음파 검사
⑤ 흉부 양쪽 측와위 촬영



문제번호	32	교수님	노병학
해설자	신나일	감수자	
주제	영상의학		
답	5		
해설	effusion이나 폐렴이 의심되는데 흉부 X선 촬영 시 병변의 위치를 정확히 어느 lobe에 있는 지 알기 위해 측와위로도 촬영해주는 것이 좋다.		

33. 62세 여자가 5일 전부터 왼쪽 가슴이 아프고 숨이 차다고 내원하였다. 기침, 가래, 발열은 없었다고 하였다. Vital sign들은 정상이었다. 과거 3년 전에 결장암을 진단받은 적이 있다고 한다. CT검사는 다음과 같다. 진단은?

- ① 중피종
② 결핵가슴막염
③ 악성가슴막삼출
④ 국한성 섬유종양
⑤ 부폐렴가슴막삼출



문제번호	33	교수님	노병학? 박순효?
해설자	신나일	감수자	
주제	영상의학		
답	3		
해설	암의 과거력과 parietal pleural의 nodule은 pleural metastasis, 악성을 시사한다. 좌측 폐에 effusion이 보이는데 pleural이 thickening 된 것으로 보아		

	exudate가 더 의심된다.
--	------------------

34. 심한 객혈로 응급실로 내원한 환자의 흉부 전산화단층촬영에서 폐국균증이 의심되었다.
가장 먼저 시행하여야 하는 치료는?

- ① 항결핵제
- ② 응급 개흉술
- ③ 지혈제 정맥주사
- ④ 기관지동맥 색전술
- ⑤ amphotericin B 정맥주사

문제번호	34	교수님	박창권
해설자	신나일	감수자	
주제	비종양성 폐질환		
답	4		
해설	교수님이 강조했던 내용이었는데 국균종(aspergilloma)에서 가장 먼저 시행해야 할 치료는 기관지 동맥 색전술이다. CT에서 fungus ball이 특징적이다. 잘 기억나진 않지만 예전 야마에 나온 적 있었음		

35. 폐암 병기 Ib에서 술후 보조항암치료(adjuvant chemotherapy)가 필요한 경우는?

- ① 폐엽절제술후 모두 시행
- ② 종양의 크기가 4cm 미만일 경우
- ③ 분화도가 좋은 경우
- ④ 흉막이 침범한 경우
- ⑤ 혈관 침범은 없는 경우

문제번호	35	교수님	박창권
해설자	신나일	감수자	
주제	폐종양 치료		
답	4		
해설	수업 중에 언급한 내용인데 분화도가 나쁘거나 4cm이상이거나 혈관 침범이 있을 때 보조항암요법을 시행한다. Stage1b에서 visceral pleural invasion 있을 때 chemo를 고려한다고 말씀하시긴 했는데.. 정확한 근거는 못 찾겠음		

36. 7차 개정 폐암 병기에 관한 기술에서 바른 사항은?

- ① 악성 흉막 삼출액이 있으면 M1b다.
- ② 5cm 보다 큰 종괴는 T3로 분류한다.
- ③ 동측에 동일 폐엽내 다발성 폐암은 T4다.
- ④ 주로 T병기 변화 보다 N병기에 초점을 두었다.
- ⑤ 반대측 폐에 발견된 폐암결절들은 M1a다.

문제번호	36	교수님	박창권
해설자	신나일	감수자	
주제	폐암의 병기 결정		
답	5		

해설	틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 악성 흉막 삼출액이 있으면 M1a이다.(11,12야마) 2. T3의 크기 기준은 7cm이상일 때이다. 3. T4는 동측에 여러 폐엽 내 다발성이다. 동일 폐엽 내는 T3이다. 4. 아마 T에 더 중점을 둔 거 같음... 수업 중에는 기준 암기하지 말고 이해만 하라고 하셨는데....
----	--

37. Tracheal surgery(기관수술)에 관한 기술 중 맞는 사항은?

- ① 기관절제 및 단단문합시 절제기관의 한계는 5cm 까지 이다.
- ② 기관은 흉부대동맥에서 직접 혈류공급을 받는다.
- ③ 기관단단문합시 양측 기관의 전후면보다 측면을 더 박리하는 것이 좋다.
- ④ 기관삽관(tracheostomy)후 stomal stenosis는 stoma의 전측부 협착이 잘 온다.
- ⑤ 기관무명동맥의 누공(tracheoinnominate artery fistula)의 치료는 누공부위를 포함한 혈관을 절제한 후 인조혈관을 연결하는 것이 효과적 수술이다.

문제번호	37	교수님	박창권
해설자	신나일	감수자	
주제	Tracheal surgery		
답	4		
해설	틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 가능한 길이는 6-7cm이다. 2. 상부식도는 inf. thyroid a, 하부 식도는 bronchial a.로부터 혈류를 공급받는다. 3. 측면보다 전후면을 박리하는 게 더 좋다. 5. 누공의 치료로 인조혈관을 연결하는 것은 효과적이지 않다. 박창권 교수님의 식도 수술 관련 문제는 옛날 야마랑 거의 유사하게 나오는 것 같으니 보기 1-5관련해서 외우면 될 거 같다.		

38. 다음중 소세포성 폐암의 치료 및 예후 인자에 대한 설명이다. 맞는 것은 ?

- ① 항암화학요법과 방사선치료로 흉곽내 폐암이 완전관해가 되면 예방적 전뇌치료는 필요없다.
- ② 소세포성폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 항암화학요법이나 방사선치료로 증상완화를 얻을 수 있다.
- ③ 폐암 중 예후가 좋은 병리형태이다.
- ④ 소세포성폐암은 방사선치료와 항암약물요법에 모두 높은 치료반응을 나타내므로 제한 병기의 소세포성 폐암은 단일 치료법으로 치료하면 된다.

문제번호	38	교수님	김진희
해설자	신나일	감수자	
주제	종양 방사선 치료		
답	2		
해설	강의록과 수업 내용을 바탕으로 틀린 보기를 정정하면 다음과 같다.		

	1. 소세포암이 완전관해/부분관해 되었을 때 Prophylactic cranial irradiation(예방적 전뇌치료)는 뇌전이를 감소시키고 생존률을 향상시킬 수 있다. 3. 폐암 중 예후가 제일 안 좋다. 생존률 : SqCC>ADC>LCC>SCLC 4. multiagent chemotherapy가 single agent보다 더 효과적이다. 김진희 교수님 문제는 예전 야마 문제들 다 모아놓고 보기들만 꼭 외우면 된다.
--	--

39. 81세 남자가 우연히 단순 폐촬영상 좌상부 폐엽에 종괴가 발견되어 내원 하였다. 과거력상 흡연력(하루 한 갑, 50년간)이 있었으며 기관지경 검사상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도조직검사상 편평상피암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화단층촬영상 폐의 종괴는1.5cm이었고 정상폐조직에 둘러싸여 있었으며 림프절은 커져 있지 않았다. PET/CT에서는 종괴에hypermetabolic lesion이 보였으나 림프절전이나 원격전이는 없었다. 폐기능 검사상 severe restrictive ventilation defect 소견이었다. 이 환자에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 병기는 T1aN0M0이며 고령이나 이 환자의 최적의 치료는 수술이다.
- ② 이 병기에서 수술 후 종격동 림프절전이가 있으면 추가적인 방사선치료는 도움이 안된다.
- ③ 내과적으로 수술이 불가능한 경우에는 SBRT (stereotactic body radiotherapy)로 완치가 가능하다.
- ④ 폐암 중 림프절전이 가능성이 가장 높은 병리형태이다.

문제번호	39	교수님	김진희
해설자	신나일	감수자	
주제	종양 방사선 치료		
답	3		
해설	틀린 보기들을 정정하면 다음과 같다. 1. severe restrictive 한 상태이므로 수술이 불가하고 SBRT로 완치가 가능하다. 2. 술 후 종격동 LN전이가 있으면 추가적인 방사선 치료로 국소재발을 감소시킬 수 있다. 4. 폐암 중 LN전이가 가장 흔한 형태는 (아마) 소세포암일 것이다.		

40. 긴장성 기흉의 치료로 가장 우선적인 것은?

- ① 기도삽관술
- ② 흉강내압의 감압
- ③ 스테로이드 주사
- ④ 마약성 진통제
- ⑤ 폐기포절제술

문제번호	40	교수님	금동윤
해설자	신나일	감수자	

주제	기흉
답	2
해설	긴장성 기흉은 pleural space에 양압이 걸린 상태로 chest tube를 통해 air를 빼 주어 감압시켜 주는게 중요하다.

41. 자연성 기흉으로 완전 폐허탈에서 보이던 환자에 흉관삽입술을 시행하였다. 시행 직후 환자는 심한 기침과 동반된 선홍색 객담을 뱉으면서 심한 호흡곤란을 호소하였다. 적절한 치료는?

- ① 즉시 흉관 제거
- ② 기도삽관
- ③ 산소공급 및 이뇨제
- ④ 지혈제
- ⑤ digitalization

문제번호	41	교수님	금동윤
해설자	신나일	감수자	
주제	기흉		
답	3		
해설	기흉 치료를 위한 흉관은 제거하면 안 되고 산소 공급과 함께 상황을 더 지켜본다. 수술은 정말 최후의 수단이다.		

42. 우상엽 절제술후 1년이 지난 환자의 흉부소견을 바르게 설명한 것은?

- ① 우측 횡격막 하측 편위
- ② 기관지 음영의 좌측 편위
- ③ 심장음영의 좌측 편위
- ④ 우측 늑간 간격 줄어듦
- ⑤ 우측 심음영의 소실

문제번호	42	교수님	금동윤
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 절제		
답	4		
해설	한 쪽 폐 절제시 일어나는 변화는 다음과 같다. ipsilateral diaphragm elevation ipsilateral mediastinal shift(trachea, heart) narrowing of intercostal space serosageous fluid accumulation heart의 contralateral 음영의 소실		

43. 55세 여자가 최근 눈꺼풀이 처지고 오후에는 조금씩 호흡곤란이 발생하여 내원하였다. 단순 흉부사진소견은 아래와 같았다. 의심되는 질환은?

- ① 과오종(harmatoma)
- ② 기형종(teratoma)
- ③ 폐암
- ④ 흉선종(thymoma)

⑤ 신경종(neurilemon)



문제번호	43	교수님	금동윤
해설자	신나일	감수자	
주제	종격동 질환		
답	4		
해설	눈꺼풀이 처진다는 대에서 thymoma 를 의심해야 한다. 커진 thymus가 aortic arch 바깥으로 하얀 음영을 나타내며 관찰된다.		

44. 2015 WHO 폐암 분류에서 선암종의 특징을 바르게 기술한 것은?

- ① Lepidic 유형이 대부분을 구성하는 선암종은 예후가 좋은 편임
- ② 최소침윤(minimally invasive)선암종은 종양의 간질 침윤 직경이 0.5cm 이하임
- ③ Solid predominant adenocarcinoma에 괴사를 보이는 경우 예후가 불량함
- ④ Micropapillary 유형을 보이는 선암종은 예후가 불량한 편임
- ⑤ 모두(1-4) 바르게 기술됨

문제번호	44	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	선암종의 특징		
답	5		
해설	강의록에 Adenocarcinoma Classification 부분 참고. 몇 장 뒤에 Grading scheme of ADC를 보면 Lepidic은 grade1이고 solid, micropapillary는 grade3이다.		

45. 폐에서 발생한 선암종을 진단하는데 도움을 주는 면역조직화학염색 마커는?

- ① EGFR, p16 and p40
- ② CK7 and TTF-1
- ③ CK5/6 and D2-40
- ④ p63 and CK7
- ⑤ CD56 and synaptophysin

문제번호	45	교수님	권건영?
해설자	신나일	감수자	
주제	선암종의 marker		
답	2		
해설	16야마랑 같은 문제이긴 한데 어느 교수님인지 어디서 배웠는지 잘 기억이 안 남..		

46. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, 호흡수 24회, 체온 36.8℃였다. 혈액 검사에서 Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L 이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 진단은?



- ① 폐렴
- ② 폐암
- ③ 폐결핵
- ④ 폐부종
- ⑤ 폐농양

문제번호	46	교수님	?
해설자	신나일	감수자	
주제	영상의학?		
답	4?		
해설			

47. 65세 남자가 호흡곤란으로 내원하였다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg 이었고, FiO₂ 0.4 의 산소를 35L/min 의 속도로 코를 통해 호흡시킨 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO₂ 85mmHg 이었다. 저산소증의 원인은?

- ① 단락
- ② 저환기
- ③ 확산장애
- ④ 환기-관류 불균형
- ⑤ 낮은 폐포내 산소분압

문제번호	47	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	저산소증의 감별		
답	4		
해설	베이스 업을 위해 1차 시험 범위이지만 2차시험에도 나왔던 문제이다. PaCO ₂ 가 증가한 상황은 아니고 O ₂ 치료로 PaO ₂ 가 상승하였으므로 V/Q		

	mismatch가 저산소증의 원인이다. 상승하지 않는다면 Shunt(단락)이다. 강의록에 Flow chart를 잘 따라가 보면 된다. 신판 해리슨에는 삭제된 chart이긴 한데 강의록에는 아마 있을 듯
--	--

48. 50세 남자가 2주전부터 열이나고 악취가 나는 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 1병씩 마셨다고 한다. 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38°C 였다. 가슴 X-선 사진이다. 진단은?



- ① 폐렴
- ② 폐암
- ③ 폐결핵
- ④ 폐부종
- ⑤ 폐농양

문제번호	48	교수님	박재석
해설자	신나일	감수자	
주제	폐농양		
답	5		
해설	베이스 업을 위해 1차 시험 범위이지만 2차시험에도 나왔던 문제이다. 가래에서 악취가 난다는 점에서부터 폐농양을 의심해야 한다. Xray 사진은 강의록에도 있는 사진인데 Cavity에 농양이 고여 평평한 수면을 이룬 AF level 을 확인할 수 있다.		

49. Thymoma에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- ① Invasive thymoma는 병리적으로 invasive한 경우에 진단할 수 있다.
- ② Posterior mediastinum에서 가장 흔한 종양이다.
- ③ Myasthenia Gravis를 동반한 Thymoma는 그렇지 않은 경우 보다 예후가 더 나쁘다.
- ④ 증상이 동반된 Thymoma에서 가장 흔한 동반질환은 Myasthenia Gravis이다.

문제번호	49	교수님	권건영? 금동윤?
해설자	신나일	감수자	
주제	Thymoma		
답	4		
해설	틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 현미경적 소견 보다는 주변 조직으로의 invasiveness에 의해 malignant가 결정된다.		

	2. Thymus는 ant. mediastinum에 위치한다. ant. mediastium의 m/c tumor이다. 참고로 m/c mediastinal tumor는 neurogenic tumor 3. Myasthenia Gravis를 동반할 경우 그렇지 않은 경우보다 예후가 좋다. 4번 보기에 설명을 덧붙이자면 환자의 절반이 Myasthenia Gravis(중증 근무력증)을 동반한다.
--	---

50. 다음 폐암의 조직형태 중 비흡연자, 젊은 연령 및 여성에서 높은 빈도를 보이며 대부분 말초형의 흔히 고립성 폐결절의 형태로 나타나는 암종은?

- ① 선암
- ② 소세포암
- ③ 대세포암
- ④ 카르시노이드
- ⑤ 편평상피세포암

문제번호	50	교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 종양		
답	1		
해설	이 문제도 마찬가지로 미리 문제와 답을 다 알려주셨음 권건영 교수님 강의록엔 Sqcc에 비해 병변이 말초에 위치해 있고 흡연력과 관계가 덜한 편이라고 강의록에 설명되어 있다		